

认知症健康素养的概念分析

罗美琳¹ 王珊珊² 陶艳玲³ 吕启圆¹

¹暨南大学护理学院, 广州 510632; ²香港理工大学护理学院, 香港 999007; ³深圳市龙岗中心医院护理部, 深圳 518116

通信作者: 吕启圆, Email: yuanqlv@163.com

【摘要】目的 分析并阐明认知症健康素养的概念内涵。**方法** 系统检索PubMed、Cochrane Library、Web of Science、Embase、中国生物医学文献服务系统、中国知网、万方数据库、维普网中与认知症健康素养相关的文献, 检索时限均为建库至2025年3月31日。由2名研究人员独立筛选文献并提取相关数据, 应用Rodgers演化概念分析法对纳入文献进行分析。**结果** 共纳入45篇文献, 其中中文文献3篇、英文文献42篇。认知症健康素养的概念属性涉及4个方面, 分别是认知症基础认知能力、全生命周期风险管理能力、参与健康决策能力、社会支持与医疗服务利用能力。前置因素包括人口学因素、社会经济因素、疾病相关因素、社会关系和环境因素; 后置影响包括降低认知症发生风险与提高认知症筛查率、提高健康相关生活质量、降低认知症污名化和病耻感等。目前尚缺乏成熟且应用广泛的认知症健康素养评估工具。**结论** 通过概念分析明确了认知症健康素养的概念属性, 以为认知症健康素养评估工具的开发提供参考。

【关键词】 老年人; 痴呆; 认知症; 健康素养; 概念分析

基金项目: 国家自然科学基金(72274078)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260205-00635

Concept analysis of dementia health literacy

Luo Meilin¹, Wang Shanshan², Tao Yanling³, Lyu Qiyuan¹

¹School of Nursing, Jinan University, Guangzhou 510632, China; ²School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong 999007, China; ³Department of Nursing, Shenzhen Longgang Central Hospital, Shenzhen 518116, China

Corresponding author: Lyu Qiyuan, Email: yuanqlv@163.com

【Abstract】Objective To analyze and clarify the conceptual connotation of dementia health literacy. **Methods** A systematic search was conducted in PubMed, Cochrane Library, Web of Science, Embase, SinoMed, China National Knowledge Infrastructure, Wanfang Data, and VIP for literature related to dementia health literacy. The search period was from the establishment of each database to March 31, 2025. Two researchers independently screened the literature and extracted relevant data. Rodgers' evolutionary concept analysis method was used to analyze the included literature. **Results** A total of 45 articles were included, including three Chinese articles and 42 English articles. The conceptual attributes of dementia health literacy involved four aspects: basic understanding of dementia, life-course risk management ability, ability to participate in health decision-making, and ability to access social support and use healthcare services. Antecedents included demographic factors, socioeconomic factors, disease-related factors, social relationships, and environmental factors. Consequences included reducing the risk of dementia, improving the dementia screening rate, improving health-related quality of life, and reducing dementia-related stigma and self-stigma. At present, mature and widely used assessment tools for dementia health literacy were still lacking. **Conclusions** This concept analysis clarifies the conceptual attributes of dementia health literacy, which is expected to provide a reference for the development of assessment tools for dementia health literacy.

【Key words】 Aged; Dementia; Cognitive disorder; Health literacy; Concept analysis

Fund program: National Natural Science Foundation of China (72274078)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260205-00635

收稿日期 2026-02-05 本文编辑 孙梦圆

引用本文: 罗美琳, 王珊珊, 陶艳玲, 等. 认知症健康素养的概念分析[J]. 中华现代护理杂志, 2026, 32(20): 000-000. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260205-00635.

痴呆是一种以获得性认知功能损害为核心,并导致患者日常生活活动能力、学习能力、工作能力和社会交往能力明显减退的综合征,其中阿尔茨海默病是最常见的痴呆类型,占有痴呆类型的60%~70%^[1-2]。目前,我国痴呆患者约1 700万例,居世界首位,预计到2040年将增长至2 900万例左右,给社会和家庭带来沉重的医疗照护负担^[3-4]。为积极应对人口老龄化,国家卫生健康委等15个部门联合印发《应对老年期痴呆国家行动计划(2024—2030年)》,明确提出到2030年公众对老年期痴呆防控知识知晓率和接受老年人健康管理服务的人群认知功能初筛率均超过80%的主要目标,并提出构建老年期痴呆友好的社会环境的总体任务^[5]。故本研究使用认知症这一易被公众接受的中性词汇作为痴呆的替代词汇^[6]。研究显示,我国公众对认知症健康素养相关问题回答正确率为55.5%,公众对认知症风险因素、症状识别、科学防治等知识掌握不足^[7]。低水平的认知症健康素养不仅会加剧社会对认知症的污名化^[8],还可能会导致认知症病耻感^[9],不利于认知症的早期诊断和管理^[10]。认知症健康素养从健康素养发展而来,但目前其概念尚未统一,阻碍了其在医疗保健、疾病预防和健康促进等领域的广泛应用。本研究采用Rodgers演化概念分析法^[11],系统梳理认知症健康素养的演化历程,明确其概念内涵,为进一步推动认知症的预防与干预提供理论支持。

一、资料与方法

1.文献检索策略:以“痴呆”“认知症”“阿尔茨海默病”“健康素养”“素养”作为中文检索词,系统检索中国知网、万方数据库、维普网和中国生物医学文献服务系统;以“dementia”“Alzheimer's disease”“health literacy”“literacy”为英文检索词,系统检索PubMed、Cochrane Library、Web of Science、Embase。检索时限均为建库至2025年3月31日。(1)文献纳入标准:研究的主要内容是认知症健康素养,涉及概念内涵、演变历程、前置因素、后置影响、测评工具和典型范例等内容中的任意1项;发表语言为中文或英文。(2)文献排除标准:重复发表的文献;会议论文;内容不完整或无法获取全文的文献。

2.资料分析方法:采用Rodgers演化概念分析法进行文献分析,具体步骤如下。(1)明确进行分析的概念,即认知症健康素养;(2)根据选定的概念筛选文献;(3)阅读文献,明确认知症健康素养演化过程;(4)确定认知症健康素养的概念属性;(5)明确认知症健康素养的前置因素、后置影响及评估工具;(6)构建认知症健康素养的典型案例。文献筛选及数据提取均由2名研究人员独立完成,意见不一致时与第3名研究人员讨论达成一致意见。

二、结果

1.文献检索结果:共检索获得12 43篇文献,经过文献筛选后最终纳入45篇文献,其中中文文献3篇,英文文献42篇。文献数量达到Rodgers演化概念分析法对纳入文献数量的要求^[12]。文献筛选流程图见图1。

2.认知症健康素养概念的演化过程:健康素养最初由美国学者Simonds^[13]于1974年提出,是指个体获得、处理健康信息和服务的能力,以及为改善自己的健康而做出正确卫生决策的能力。世界卫生组织将健康素养定义为个体获取、理解、采纳健康信息服务,并利用其做出正确判断和决定,促进自身健康的能力^[14]。随着健康素养的发展,认知症健康素养逐渐受到关注。2009年,Low和Anstey^[15]首次提出认知症健康素养概念,即与认知症相关的知识和信念,并对2 000名澳大利亚居民进行认知症健康素养的调查,结果显示82%的人群能正确识别认知症。该定义有助于认知症的识别、管理和预防。2015年,Noble等^[16]将阿尔茨海默病健康素养定义为学习阿尔茨海默病主要症状的能力,并开发了针对阿尔茨海默病的健康教育课程。2022年,Nguyen等^[17]提出认知症健康素养不仅包括与认知症相关的知识和信念,还涉及在相关的情境下进行决策的能力,并首次系统总结了提升认知症健康素养的干预措施。之后,Fernandez Cajavilca和Sadarangani^[18]对认知症患者非正式照护者的认知症健康素养进行概念分析,即照护者获取认知症相关知识的能力,以便进行照护决策、识别照护中的缺口,并获得必要的资源来长期照护患者,同时维持与跨学科专业团队的协作关系。尽管不同研究者对认知症相关健康素养的定义存在一定共性,

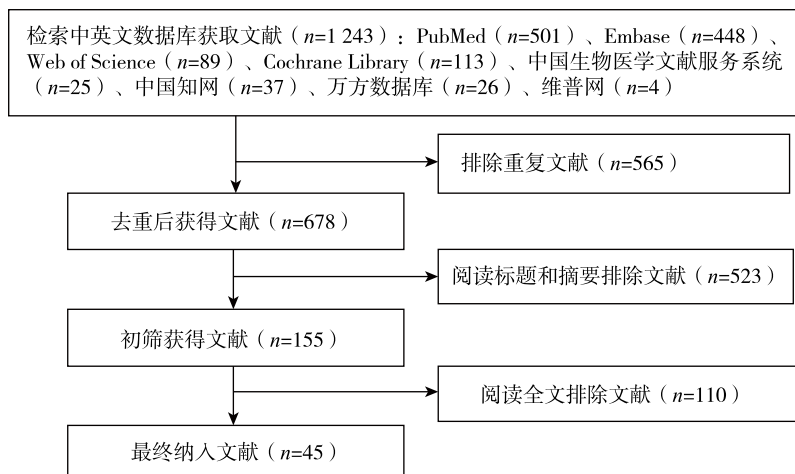


图1 文献筛选流程图

但目前尚未形成统一概念。

3. 认知症健康素养的概念属性: 一个概念所具有的特征或现象称为该概念的概念属性^[19]。经过文献分析、整合、归纳, 本研究得出认知症健康素养具有4个方面的属性。(1) 认知症基础认知能力。认知症基础认知能力是认知症健康素养的基本属性, 与Nutbeam^[20]健康素养模型中的功能性健康素养相对应, 该属性强调个体能够主动获取和理解认知症的基本知识、识别早期症状并对认知症持有科学的态度。目前国内外常用的认知症知识评估量表(Dementia Knowledge Assessment Scale, DKAS)包含了认知症基础认知维度^[21], 涉及认知症病因与特征、风险因素、健康促进活动内容。Low和Anstey^[15]对澳大利亚公众认知症知识和信念的调查结果显示, 约一半的受试者认为通过适当的治疗可以治愈认知症, 表明公众对认知症不可逆性的特征认识不足。同样, 我国公众也缺乏对认知症的正确认知, 普遍认为认知症是衰老过程中的正常现象, 并将其视为带有污名化的精神疾病^[8]。一项关于中国公众对认知症相关因素的横断面调查结果显示, 大多数人能正确认识到生活方式(如吸烟、饮酒、运动、阅读、智力游戏和社交活动等)与疾病发生具有相关性, 但对医疗因素的认知不足, 如高血压、糖尿病、降压和降脂药物的使用等, 这可能与疾病预防的宣传内容更侧重生活方式有关^[22]。(2) 全生命周期风险管理能力。认知症健康素养是贯穿个体整个生命周期的动态能力, 该属性强调强化公众对认知症可干预风险因素的认知。全生命周期模型指出在生命历程的任何阶段, 通过干预或调整生活方式都可能改变认知症的发生风险^[23]。研究表明, 全球45%的认知症可归因于14个可改变的风险因素, 并倡议根据全生命周期模型进行风险因素预防, 青年时期重点关注低文化程度人群; 中年时期关注听力障碍、低密度脂蛋白胆固醇水平高、抑郁、创伤性脑损伤、缺乏体育锻炼、糖尿病、吸烟、高血压、肥胖、过量饮酒人群; 晚年时期关注社交接触少、空气污染和视力受损人群^[24]。基于国外研究的启发, 我国学者对认知症高危人群进行了个性化干预, 结果显示基于全生命周期模型的多领域干预不仅有效降低了认知症风险, 还能提升认知功能^[25]。(3) 参与健康决策能力。健康决策作为健康素养的重要环节, 是认知症健康素养的核心技能, 与Nutbeam^[20]健康素养模型中提出的批判性健康素养相似, 旨在强调个体在健康决策中发挥主观能动性。世界卫生组织强调, 公众应在认知症预防、筛查与干预策略中积极参与健康决策^[26]。尽管认知症患者的认知功能可能有所下降, 但许多认知症患者仍能准确地表达其个人价值观和选择偏好^[27]。认知症患者、家庭成员和医疗保健提供者共同参与决策过程, 能使治疗和照护更加符合患者的偏好和需求。(4) 社会支持与医疗服务利用能力。社会支持与医疗服务利用能力是认知症健康素养在宏观层面的重要体现。社会支持是认知症预防和干预的重要外部资源, 良好的社会支持网络(包括家庭成员、朋友、邻里及社区), 能够有效缓冲认知功能下降对个体造成的负面影响, 改善患者的生活质量与情绪状态^[24]。Doherty等^[28]指出社会支持和医疗服务利用能力是衡量个体认知症健康素养的主

要维度, 强调了个体获取社会支持以及医疗服务的重要性。在复杂的医疗体系中, 判断医疗服务可及性的能力是个体有效“导航”的关键技能, 对认知症患者健康需求的满足尤为重要^[6]。然而, 目前认知症服务在需求方与供应方之间存在不匹配的问题, 甚至部分医疗保健人员对相关资源缺乏足够的了解, 阻碍了个体对医疗服务的获取与利用^[29]。

4. 认知症健康素养的前置因素: (1) 人口学因素。研究显示, 高龄、男性、未婚、独居等是认知症健康素养的危险因素^[8, 30-32]。Aihara和Maeda^[30]对854名老年人进行认知症健康素养的调查显示, 75岁以上老年人的认知症健康素养水平低于65~74岁老年人, 且年龄每增加1岁, 个体低认知症健康素养风险升高9%。分析原因: 一方面, 随着年龄的增加, 老年人的听觉和视觉功能逐渐下降, 健康信息获取途径减少; 另一方面, 随着年龄的增长导致认知功能衰退, 从而导致老年人阅读、推理以及计算等功能性健康素养水平下降^[33]。鉴于认知症与高龄密切相关, 提高老年人群的认知症健康素养水平尤为重要^[30]。女性认知症健康素养水平往往高于男性, 一方面可能是在中国传统文化中, 女性更多地参与家庭照顾与社区服务, 有更多机会获取认知症相关信息^[7]; 另一方面可能是比起男性, 女性往往能更积极地寻找并分享健康相关信息^[34]。(2) 社会经济因素。社会经济水平影响认知症健康素养^[8]。受过高等教育的人往往比受教育程度低的人更了解认知症相关知识^[35]。对认知症的风险因素和预防措施有更高认知水平的个体, 其更愿意采取相关健康行为^[36]。经济水平与认知症健康素养水平具有正相关关系^[7], 社会经济地位低下可能会限制个体获取和理解认知症健康信息的途径^[37]。(3) 疾病相关因素。研究表明, 健康素养水平与认知功能之间存在直接且双向关系^[37]。一方面, 认知功能障碍不利于个体获得健康信息和做出健康决策^[38]。另一方面, 对于健康素养水平较低的个体, 随着时间的推移, 认知功能下降的速度明显加快^[9]。随着年龄的增长, 听力和视力功能下降会导致认知症健康素养水平下降^[30]。抑郁症是认知症健康素养的危险因素, 抑郁症患者往往会减少对社区活动的参与, 从而减少获取知识的机会^[7-8]。(4) 社会关系和环境因素。认知症患者接触史、医务人员支持及充足的社会支持有利于认知症健康素养水平的提升^[8, 39]。有认知症患者接触史的个体, 对认知症症状、疾病进展及照护需求有一定的敏感度, 能获取更多相关知识。医务人员有较完善的医学知识体系, 与其接触更容易获取认知症相关信息。充足的社会支持能促进健康信息的传播与共享, 帮助个体获取更全面的认知症知识; 社区组织或专业团队提供的健康教育, 能够有效降低信息获取的门槛。

5. 认知症健康素养的后置影响: (1) 降低认知症发生风险与提高认知症筛查率。低健康素养水平是认知症的危险因素^[37], 提升认知症健康素养水平成为实现认知症早期筛查的重要策略之一。认知症健康素养与个体的认知筛查意愿具有正相关关系^[40], 认知症健康素养水平较高的人群更愿意接受认知筛查^[30]。通过认知筛查帮助高风险人群实现早发现、及时干预与规范治疗, 从而推动认知症管理关口前移^[5]。

《成人健康体检项目推荐指引(2025年版)》^[41]首次将认知筛查纳入成人健康体检中,推荐 ≥ 50 岁的人群开展脑认知健康筛查,对于有认知症危险因素、认知障碍家族史及主观认知下降的人群,筛查年龄可提前至40岁或根据个体化情况及早筛查等。(2)提高健康相关生活质量。高水平的健康相关生活质量是成功老龄化的重要指标^[42]。健康相关生活质量是指个人感知的健康状况,反映主观感受和满意度,可用于评估个体的健康状况^[43]。研究显示,慢性病患者的健康素养水平与健康相关生活质量水平具有正相关关系^[44],轻度认知障碍患者的健康素养水平与其健康状况具有正相关关系^[45],且健康素养水平越高,自我管理能力强^[46]。具备较高的认知症健康素养水平的个体更能够早期识别疾病症状,主动寻求医疗建议,并采取有效的健康管理措施,最终有效提升健康相关生活质量水平。(3)降低认知症污名化和病耻感。高水平的认知症健康素养能有效减少个体对认知症的病耻感,降低污名化^[47]。目前中国公众对认知症呈积极态度^[48]。但公众对认知症的污名化仍然是普遍现象,新加坡的一项针对公众认知症知识与态度的调查显示,有10%的研究对象表示不想知道自己被诊断为认知症,19%的研究对象对被诊断患有认知症感到尴尬^[49]。未来应开展更多认知症相关疾病知识科普宣传,并通过多种渠道将认知症友好性的理念传递给公众,有利于缓解认知症污名化现象^[47,50]。

6. 认知症健康素养的评估工具:为客观、科学评估认知症健康素养水平,研究者已开发多种特异性评估工具,本研究对目前比较有代表性的3种工具进行介绍。(1)阿尔茨海默病知识量表(Alzheimer's Disease Knowledge Scale, ADKS)。由Carpenter等^[51]为测量公众关于阿尔茨海默病知识素养水平而开发,该量表共有30个条目,共7个维度,采用“是”或“否”让受试者进行回答,回答正确计1分,总分为30分,得分越高说明受试者认知症相关知识掌握程度越好。该量表的Cronbach's α 系数为0.71,重测信度为0.81,折半信度为0.55。该量表于2013年由我国学者贺润莲等^[52]汉化,中文版ADKS的Cronbach's α 系数为0.756,总量表分半信度为0.556,总体来说信效度较好,适用于照护者、患者及医护人员的阿尔茨海默病知识测量。(2)DKAS。由Annear等^[21]于2015年研制,共27个条目,内容涵盖了原因和特征、沟通和行为、护理考虑、健康风险和促进4个相关领域的内容。2017年,Annear等^[53]在探索性因子分析的基础上进行了验证性因子分析,结果显示DKAS的Cronbach's α 系数为0.85。目前该量表已被张桂菊等^[54]汉化,总量表的Cronbach's α 系数为0.840,各分量表的Cronbach's α 系数为0.826~0.957,量表平均水平内容效度指数为0.90,总量表的重测信度为0.83。中文版DKAS具有良好的信度和效度,符合量表的心理学测量要求,适用于测量我国认知症患者照顾者的认知症知识水平。(3)衡量消费者对认知症服务和信息的获取、评估和应用量表(Consumer Access, Appraisal and Application of Services and Information for Dementia, CAAASI-Dem)。由Doherty等^[28]针对认知症相关人群(即认知症患者、正式照顾

者以及非正式照顾者)开发的健康素养评估量表,包括评估和参与、准备程度、社会支持、特定认知症服务以及实践方面包括5个维度,共26个条目。此后,该团队继续优化量表内容,最终形成包括5个维度、24个条目的量表^[55]。目前该量表只有英文版。

7. 典型案例:刘奶奶,65岁,大专学历,退休前在工厂工作,与子女同住。在某次社区医院体检时,她了解到有免费的认知症筛查活动,社区护士使用简易精神状态检查表(Minimum Mental State Examination, MMSE)对其进行认知功能评估,筛查结果显示MMSE评分为24分,提示存在认知障碍。社区医务人员建议她前往三甲医院神经内科进一步诊断,并为她建立了健康档案。经过专业检查后,刘奶奶确诊为阿尔茨海默病,医生建议通过规范药物治疗、改善生活方式、认知训练等多项干预措施改善其认知功能。在干预方案讨论中,刘奶奶主动提出自己的疑问和需求,在医生、护士、家属的帮助下共同制订了个性化方案,包括按时服药、社区认知训练、家庭饮食调整以及定期健康监测等。刘奶奶严格遵医嘱服药,改变饮食结构,每周定期到社区医院进行认知训练,社区护士定期为其进行认知功能评估,刘奶奶定期到医院神经内科门诊复诊。在家庭、社区与医院的协作下,经过6个月的个性化干预,刘奶奶的MMSE评分为24分,认知功能维持稳定。在上述过程中,刘奶奶的认知症健康素养水平亦有提升。首先,刘奶奶了解到阿尔茨海默病的疾病信息,包括疾病特点、干预方法及日常注意事项,对自身病情有基础认知。确诊后,刘奶奶严格遵医嘱规律服药,并在家人协助下进行饮食调整,体现出参与健康决策与获取社会支持的能力。此外,刘奶奶主动向社区医务人员咨询疾病相关问题,并积极配合认知训练,体现了较好的医疗服务利用能力。

8. 概念的界定和框架:综上所述,本研究将认知症健康素养定义为个体能够主动获取并理解认知症的基本知识,基于全生命周期视角识别可改变危险因素并积极采取应对措施,在认知筛查与干预过程中参与决策,同时获取良好的社会支持并有效利用医疗服务的动态综合能力。认知症健康素养概念框架见图2。

9. 启示:(1)重视认知症全民科普。在健康老龄化背景下对公众进行认知症相关知识普及,通过系统性的健康教育,增强公众对认知症的正确认知,促进疾病早期诊断与干预。针对公众,可借鉴认知症反污名化传播策略,采取故事叙事方式进行认知症知识科普^[56],以降低公众对疾病的偏见,提高公众对认知症的正确认知水平与接纳度。针对高风险人群,需要分析其需求并提供必要的信息支持,在特定的医疗情况下做出科学的决策^[38]。针对照顾者,应聚焦信息甄别及医疗系统导航支持,同时保持与跨学科专业服务团队的紧密联系,以提升长期照护服务的可及性^[18]。建议将目前已明确的14个认知症危险因素纳入常规健康教育计划中^[24],制订社区及社会层面的健康教育方案,开展疾病知识科普,以增强公众对认知健康的知识和信念水平^[9]。研究显示,有较高文化水平且在岗人群会更倾向于在政府或者医院相关网站上搜索健康信息;中年人、失业者或退休

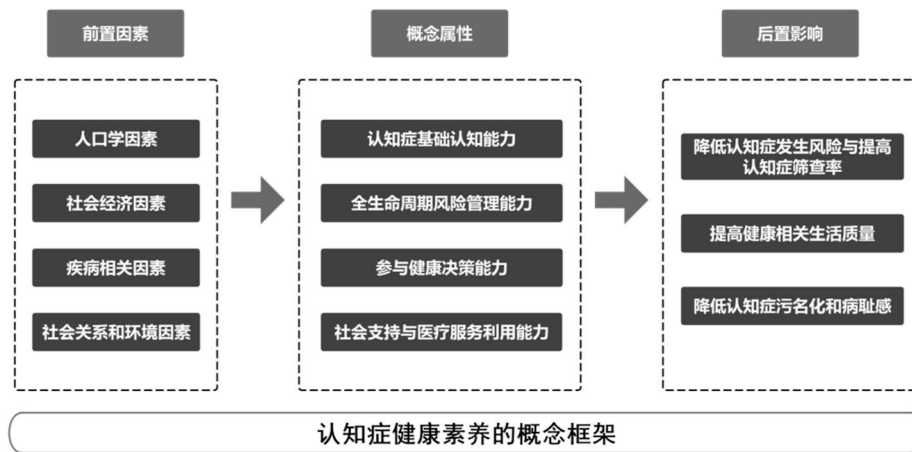


图2 认知症健康素养的概念框架

人群往往通过电视或广播等了解认知症^[32]。(2)重视社区居民认知症筛查。提高公众意识和提供认知筛查是促进认知症筛查可及性的关键策略。医疗保健提供者可通过有意识地提供认知症资源信息,协助认知症患者和照顾者有效获取、理解并利用认知症相关信息^[57]。《国家卫生健康委办公厅关于开展老年痴呆防治促进行动(2023—2025年)的通知》^[58]强调,开展老年人认知功能筛查及早期干预,指导有条件的地区结合实际为辖区内65岁及以上常住居民每年提供1次认知功能初筛。该举措旨在通过系统性的筛查措施,早期发现认知功能异常者,及时采取有效的管理和治疗策略。(3)基于全生命周期进行多领域干预。在生命各个阶段,都存在着与认知症相关的潜在危险因素^[23]。基于全生命周期多领域干预策略为降低认知症风险提供了有效策略,有利于降低认知症发生风险,并对与年龄相关的非病理性认知功能衰退具有积极的预防作用^[59-60]。从全生命周期角度对认知症危险因素进行多领域干预,不仅能有效降低认知症的发生风险,还能进一步提升公众的认知症健康素养水平。

三、讨论

本研究基于Rodgers演化概念分析法界定了认知症健康素养的4个概念属性、前置因素、后置影响及评估工具,并通过构建典型案例,深入阐释了认知症健康素养的概念内涵。在此基础上,结合当前国内外认知症健康素养的研究现状,提出了未来提高公众认知症健康素养水平的建议。未来研究者可以从以下方面进一步开展研究:(1)我国关于认知症健康素养的测量工具比较单一^[61],大多集中在功能性健康素养测评,而忽略了互动性和批判性健康素养,未来应开发综合性的认知症健康素养的测量工具,以更加准确地评估我国公众的认知症健康素养水平。(2)目前的认知症健康教育方案的理论基础多沿用普适性理论^[62],认知症作为一种多因素、长病程和高照护需求的疾病,需要构建科学的认知症健康素养模型,以作为健康教育开展的理论支撑。(3)目前国内认知症健康素养干预方案的构建与实施仍存在不足,未来研究者应针对不同人群构建个性化的认知症健康素养干预方案并应用^[63]。认知症健康素养是一个动态发展的概念,

当前对该概念的界定仅能反映现阶段的研究现状,随着未来研究的深入,认知症健康素养概念可能会被不断拓展并呈现出新的属性和内涵。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 罗美琳:构思与设计、文献调研与整理、论文撰写、论文修订;王珊珊:研究指导、论文修订;陶艳玲:研究指导、论文修订;吕启圆:论文审校、获取资助

参 考 文 献

- [1] 中国痴呆与认知障碍指南写作组,中国医师协会神经内科医师分会认知障碍疾病专业委员会. 2018中国痴呆与认知障碍诊治指南(一):痴呆及其分类诊断标准[J]. 中华医学杂志, 2018, 98(13): 965-970. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.13.003.
- [2] 岳玲,江叶昊. 阿尔茨海默病诊断和分期新标准:生物标志物引领的精准医疗时代[J]. 神经病学与神经康复学杂志, 2025, 21(1): 1-5. DOI: 10.12022/jnnr.2024-0261.
- [3] Yue L, Jiang YH. New diagnostic and staging criteria for Alzheimer's disease: the era of precision medicine led by biomarkers[J]. J Neurol Neurorehabil, 2025, 21(1): 1-5.
- [4] Zhi N, Ren R, Qi J, et al. The China Alzheimer report 2025[J]. Gen Psychiatr, 2025, 38(4): e102020. DOI: 10.1136/gpsych-2024-102020.
- [5] Zhu P, Yang Q, Chen J, et al. Forecasting long-term care demands for dementia in China (2020 - 2040): a Markov model analysis of urban-rural disparities[J]. Int J Nurs Stud, 2026, 176: 105328. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2025.105328.
- [6] 国家卫生健康委等15个部门关于联合印发《应对老年痴呆国家行动计划(2024—2030年)》的通知[EB/OL]. (2024-12-31) [2026-01-20]. <https://www.nhc.gov.cn/ljks/c100158/202501/4b4476877f21467fbfcea71bc90d8313.shtml>.
- [7] 王迪,李现文. 基于SEIPS模型的认知症激越行为照护体验的质性研究[J]. 护理学报, 2023, 30(8): 23-28. DOI: 10.16460/j.issn1008-9969.2023.08.023.
- [8] Zhang H, Loi SM, Zhou S, et al. Dementia literacy among community-dwelling older adults in urban China: a cross-sectional study[J]. Front Public Health, 2017, 5: 124. DOI: 10.3389/fpubh.2017.00124.
- [9] Sun F, Wang K, Shen Y, et al. Dementia literacy and worry among older Chinese Americans in Arizona: a comparison

- between 2013 and 2017 [J]. *Int Psychogeriatr*, 2023, 35(1): 43-53. DOI: 10.1017/S1041610221001289.
- [9] Rooha A, Shetty S, Bajaj G, et al. Development and validation of educational multimedia to promote public health literacy about healthy cognitive aging[J]. *Health Expect*, 2023, 26(6): 2571-2583. DOI: 10.1111/hex.13857.
- [10] Smith BJ, Ali S, Quach H. Public knowledge and beliefs about dementia risk reduction: a national survey of Australians[J]. *BMC Public Health*, 2014, 14: 661. DOI: 10.1186/1471-2458-14-661.
- [11] Toftagen R, Fagerström LM. Rodgers' evolutionary concept analysis: a valid method for developing knowledge in nursing science[J]. *Scand J Caring Sci*, 2010, 24 Suppl 1: 21-31. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2010.00845.x.
- [12] 李晴歌, 胡嘉乐, 郑窑文, 等. 概念分析方法及在护理研究中的应用[J]. *护理学杂志*, 2018, 33(4): 100-102. DOI: 10.3870/j.issn.1001-4152.2018.04.100.
- Li QG, Hu JL, Zheng YW, et al. Concept analysis and its application in nursing[J]. *J Nurs Sci*, 2018, 33(4): 100-102.
- [13] Simonds SK. Health education as social policy[J/OL]. *Health Education & Behavior*, 1974, 2(1_suppl): 1-10 [2026-05-18]. <https://doi.org/10.1177/10901981740020S102>. DOI: 10.1177/10901981740020S102.
- [14] World Health Organization. The bangkok charter for health promotion in a globalized world[J]. *Health Promot J Austr*, 2005, 16(3): 168-171.
- [15] Low LF, Anstey KJ. Dementia literacy: recognition and beliefs on dementia of the Australian public[J]. *Alzheimers Dement*, 2009, 5(1): 43-49. DOI: 10.1016/j.jalz.2008.03.011.
- [16] Noble JM, Hedmann MG, Williams O. Improving dementia health literacy using the FLOW mnemonic: pilot findings from the Old SCHOOL hip-hop program[J]. *Health Educ Behav*, 2015, 42(1): 73-83. DOI: 10.1177/1090198114537063.
- [17] Nguyen H, Phan HT, Terry D, et al. Impact of dementia literacy interventions for non-health-professionals: systematic review and meta-analysis[J]. *Aging Ment Health*, 2022, 26(3): 442-456. DOI: 10.1080/13607863.2021.1884843.
- [18] Fernandez Cajavilca M, Sadarangani T. Dementia-literate informal caregivers: an evolutionary concept analysis[J]. *Nurs Outlook*, 2024, 72(5): 102224. DOI: 10.1016/j.outlook.2024.102224.
- [19] Rezaei-Adaryani M, Salsali M, Mohammadi E. Nursing image: an evolutionary concept analysis[J]. *Contemp Nurse*, 2012, 43(1): 81-89. DOI: 10.5172/conu.2012.43.1.81.
- [20] Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century[J]. *Health Promot Int*, 2000, 15(3): 259-267. DOI: 10.1093/heapro/15.3.259.
- [21] Annear MJ, Toye CM, Eccleston CE, et al. Dementia Knowledge Assessment Scale: development and preliminary psychometric properties[J]. *J Am Geriatr Soc*, 2015, 63(11): 2375-2381. DOI: 10.1111/jgs.13707.
- [22] Zheng YB, Shi L, Gong YM, et al. Public awareness and knowledge of factors associated with dementia in China[J]. *BMC Public Health*, 2020, 20(1): 1567. DOI: 10.1186/s12889-020-09665-7.
- [23] Department of Error[J]. *Lancet*, 2023, 402(10408): 1132. DOI: 10.1016/S0140-6736(23)02043-3.
- [24] Livingston G, Huntley J, Liu KY, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission[J]. *Lancet*, 2024, 404(10452): 572-628. DOI: 10.1016/S0140-6736(24)01296-0.
- [25] Meng X, Su J, Gao T, et al. Multidomain interventions based on a life-course model to prevent dementia in at-risk Chinese older adults: a randomized controlled trial[J]. *Int J Nurs Stud*, 2024, 152: 104701. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2024.104701.
- [26] World Health Organization. Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines[M]. Geneva: World Health Organization, 2019.
- [27] Mattos MK, Gibson JS, Wilson D, et al. Shared decision-making in persons living with dementia: a scoping review[J]. *Dementia (London)*, 2023, 22(4): 875-909. DOI: 10.1177/14713012231156976.
- [28] Doherty KV, Nguyen H, Eccleston C, et al. Measuring consumer access, appraisal and application of services and information for dementia (CAAASI-Dem): a key component of dementia literacy[J]. *BMC Geriatr*, 2020, 20(1): 484. DOI: 10.1186/s12877-020-01891-3.
- [29] Duran-Kıraç G, Uysal-Bozkir Ö, Uittenbroek R, et al. Accessibility of health care experienced by persons with dementia from ethnic minority groups and formal and informal caregivers: a scoping review of European literature[J]. *Dementia (London)*, 2022, 21(2): 677-700. DOI: 10.1177/14713012211055307.
- [30] Aihara Y, Maeda K. Dementia literacy and willingness to dementia screening[J]. *Int J Environ Res Public Health*, 2020, 17(21): 8134. DOI: 10.3390/ijerph17218134.
- [31] Sun YJ, Song J, Li XP, et al. Knowledge of Alzheimer's disease and associated factors among adults in Zhuhai, China: a cross-sectional analysis[J]. *BMC Public Health*, 2024, 24(1): 1769. DOI: 10.1186/s12889-024-19289-w.
- [32] Leung A, Molassiotis A, Zhang J, et al. Dementia literacy in the Greater Bay Area, China: identifying the at-risk population and the preferred types of mass media for receiving dementia information[J]. *Int J Environ Res Public Health*, 2020, 17(7): 2511. DOI: 10.3390/ijerph17072511.
- [33] Kobayashi LC, Wardle J, Wolf MS, et al. Aging and functional health literacy: a systematic review and meta-analysis[J]. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci*, 2016, 71(3): 445-457. DOI: 10.1093/geronb/gbu161.
- [34] Pacifico D, Fiordelli M, Fadda M, et al. Dementia is (not) a natural part of ageing: a cross-sectional study on dementia knowledge and misconceptions in Swiss and Italian young adults, adults, and older adults[J]. *BMC Public Health*, 2022, 22(1): 2176. DOI: 10.1186/s12889-022-14578-8.
- [35] Lee JY, Park S, Kim KW, et al. Differences in knowledge of dementia among older adults with normal cognition, mild cognitive impairment, and dementia: a representative nationwide sample of Korean elders[J]. *Arch Gerontol Geriatr*, 2016, 66: 82-88. DOI: 10.1016/j.archger.2016.04.013.
- [36] Nafilyan V, Eley S, Courtin E. Differences in dementia prevention knowledge by educational attainment: an analysis of a household survey from Great Britain[J]. *BMJ Public Health*, 2024, 2(2): e001479. DOI: 10.1136/bmjph-2024-001479.
- [37] Oliveira D, Bosco A, di Lorito C. Is poor health literacy a risk factor for dementia in older adults? Systematic literature review of prospective cohort studies[J]. *Maturitas*, 2019, 124: 8-14. DOI: 10.1016/j.maturitas.2019.03.010.
- [38] Rostamzadeh A, Stapels J, Genske A, et al. Health literacy in

- individuals at risk for Alzheimer's dementia: a systematic review [J]. *J Prev Alzheimers Dis*, 2020, 7(1): 47-55. DOI: 10.14283/jpad.2019.34.
- [39] Wuttke A, Palm S, Geschke K, et al. Public knowledge and attitudes about mental health in older age in Germany: focus on dementia and late-life depression[J]. *Prev Med Rep*, 2023, 35: 102384. DOI: 10.1016/j.pmedr.2023.102384.
- [40] Khalil M, Shaala RS, Mousa E, et al. Dementia health matters: influence of literacy, fears, and endorsements on dementia risk mitigation and screening among community-dwelling older adults[J]. *Geriatr Nurs*, 2025, 61: 513-525. DOI: 10.1016/j.gerinurse.2024.12.022.
- [41] 国家卫生健康委办公厅. 成人健康体检项目推荐指引(2025年版) [EB/OL]. (2025-10-28) [2026-01-20]. <https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202511/4feab6de63e44cb9fd4ac8f579ca279.shtml>.
- [42] Kim HS, Kim J, Kim JA. Mediating role of health literacy in relationship between frailty and health-related quality of life in community-dwelling older adults[J]. *PLoS One*, 2024, 19(5): e0303164. DOI: 10.1371/journal.pone.0303164.
- [43] Romero M, Vivas-Consuelo D, Alvis-Guzman N. Is health related quality of life (HRQoL) a valid indicator for health systems evaluation?[J]. *Springerplus*, 2013, 2: 664. DOI: 10.1186/2193-1801-2-664.
- [44] Song I. Relationship between health literacy and health-related quality of life in Korean adults with chronic diseases[J]. *PLoS One*, 2024, 19(4): e0301894. DOI: 10.1371/journal.pone.0301894.
- [45] Kim CY, Choi BY, Ryoo SW, et al. Health literacy and health-related quality of life in older adults with mild cognitive impairment[J]. *J Am Med Dir Assoc*, 2024, 25(11): 105253. DOI: 10.1016/j.jamda.2024.105253.
- [46] 王韵娴, 林榕, 李红. 轻度认知功能障碍患者自我管理研究进展[J]. *军事护理*, 2023, 40(1): 74-76, 111. DOI: 10.3969/j.issn.2097-1826.2023.01.018.
- Wang YX, Lin R, Li H. Review on self-management of patients with mild cognitive impairment[J]. *Mil Nurs*, 2023, 40(1): 74-76, 111.
- [47] Chang CY, Hsu HC. Relationship between knowledge and types of attitudes towards people living with dementia[J]. *Int J Environ Res Public Health*, 2020, 17(11): 3777. DOI: 10.3390/ijerph17113777.
- [48] Yang T, Huang Y, Li X, et al. Knowledge, attitudes, and stigma related to dementia among illiterate and literate older adults in Shanghai[J]. *Risk Manag Healthc Policy*, 2021, 14: 959-966. DOI: 10.2147/RMHP.S296044.
- [49] Hansra GK, Lim H, Cheong CY, et al. Knowledge and attitudes towards dementia among the general public in Singapore: a comparative analysis[J]. *Dement Geriatr Cogn Disord*, 2023, 52(4): 214-221. DOI: 10.1159/000530271.
- [50] Lee SE, Hong M, Casado BL. Alzheimer's disease (AD) knowledge in Korean Americans: identifying knowledge gaps and misconceptions and examining predictors of AD knowledge[J]. *Ethn Health*, 2023, 28(3): 431-445. DOI: 10.1080/13557858.2022.2045907.
- [51] Carpenter BD, Balsis S, Otilingam PG, et al. The Alzheimer's Disease Knowledge Scale: development and psychometric properties[J]. *Gerontologist*, 2009, 49(2): 236-247. DOI: 10.1093/geront/gnp023.
- [52] 贺润莲, 景彩丽, 李变娥, 等. 中文版阿尔茨海默病知识量表信效度研究[J]. *中华护理杂志*, 2013, 48(9): 835-837. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2013.09.022.
- He RL, Jing CL, Li BE, et al. Reliability and validity of the Chinese version of the Alzheimer's Disease Knowledge Scale[J]. *Chin J Nurs*, 2013, 48(9): 835-837.
- [53] Annear MJ, Teye C, Elliott KJ, et al. Dementia Knowledge Assessment Scale (DKAS): confirmatory factor analysis and comparative subscale scores among an international cohort[J]. *BMC Geriatr*, 2017, 17(1): 168. DOI: 10.1186/s12877-017-0552-y.
- [54] 张桂菊, 陈颖, 谢舒棠, 等. 痴呆知识评估量表的汉化及信效度研究[J]. *护理研究*, 2019, 33(1): 42-45. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2013.09.022.
- [55] Nguyen H, Doherty KV, Eccleston C, et al. Consumer Access, Appraisal, and Application of Services and Information for Dementia (CAAASI-Dem): a validation study[J]. *Aging Ment Health*, 2022, 26(12): 2489-2495. DOI: 10.1080/13607863.2021.1991277.
- [56] Mondragón Bohórquez SP, Gutiérrez-López C. Scope of anti-stigma programs against Alzheimer's disease: a scoping review[J]. *PLOS Ment Health*, 2025, 2(8): e0000406. DOI: 10.1371/journal.pmen.0000406.
- [57] Kimzey M, Howe CJ, Martin C, et al. Development of health literacy in persons and caregivers living with dementia: a qualitative directed content analysis[J]. *Dementia (London)*, 2022, 21(2): 540-555. DOI: 10.1177/14713012211049691.
- [58] 国家卫生健康委办公厅. 国家卫生健康委办公厅关于开展老年痴呆防治促进行动(2023—2025年)的通知[EB/OL]. (2023-05-26) [2026-02-05]. <https://www.nhc.gov.cn/ljks/c100158/202306/6a4c7f7a6f0c47cbb609a07e7f78582d.shtml>.
- [59] Tomaszewski Farias S, Fox J, Dulaney H, et al. Memory support training and lifestyle modifications to promote healthy aging in persons at risk for Alzheimer's disease: a digital application supported intervention (Brain Boosters) [J]. *BMC Geriatr*, 2023, 23(1): 881. DOI: 10.1186/s12877-023-04574-x.
- [60] Isaacson RS, Hristov H, Saif N, et al. Individualized clinical management of patients at risk for Alzheimer's dementia[J]. *Alzheimers Dement*, 2019, 15(12): 1588-1602. DOI: 10.1016/j.jalz.2019.08.198.
- [61] 王冰洁, 梁琪, 刘洋, 等. 老年人痴呆素养的研究进展[J]. *护理管理杂志*, 2023, 23(12): 926-930. DOI: 10.3969/j.issn.1671-315x.2023.12.011.
- Wang BJ, Liang Q, Liu Y, et al. Dementia literacy among the elderly: a literature review[J]. *J Nurs Adm*, 2023, 23(12): 926-930.
- [62] Shi L, Wu B, Liu X, et al. Health changes from trans-theoretical model-based education in older adults with mild cognitive impairment: a randomized controlled trial[J]. *Int J Nurs Stud*, 2025, 162: 104961. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2024.104961.
- [63] 李华, 张巾英, 王黎, 等. 成年人痴呆预防信念对健康促进生活方式的影响研究[J]. *中国全科医学*, 2023, 26(13): 1584-1589, 1597. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0752.
- Liu H, Zhang JY, Wang L, et al. Effect of dementia prevention beliefs on health promoting lifestyle in Chinese adults[J]. *Chinese General Practice*, 2023, 26(13): 1584-1589, 1597.